

Obezita ako zdravotnícka „nákladová“ diagnóza: čo znamená pre prístup k GLP-1 liečbe a nepriamo aj pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.10.2026



Ilustračná scéna. O dostupnosti liečby nerozhoduje len účinok — a dôsledky nesie aj nefrológia.

Obezita sa v systémoch zdravotnej starostlivosti čoraz častejšie posudzuje aj cez optiku nákladov — nielen ako klinická diagnóza, ale ako položka, ktorá generuje ďalšie a ďalšie výdavky. Článok na Medscape od Amy Faith Ho (MD, MPH) rozoberá dilemu, či má systém platiť za obezitu ako za prevenciu (drahými liekmi zo skupiny GLP-1), alebo bude aj naďalej hradiť najmä jej neskoršie následky. Hoci ide o americkú zdravotnú politiku (Medicare a Medicaid), otázka má priamy dosah aj na nefrológiu.

Prečo by sa nefrológ mal zaujímať

Obezita nie je len „metabolický problém“. Je to dlhodobý spúšťač hypertenzie, diabetu 2. typu, dyslipidémie, spánkového apnoe a systémového zápalu. V nefrológii sa tieto súvislosti neskôr často prejavujú rýchlejšou progresiou chronickej choroby obličiek (CKD), vyšším kardiovaskulárnym rizikom a väčším počtom pacientov na dialýze. Rozhodnutia o úhrade a dostupnosti účinnej liečby preto nie sú iba otázkou „zdravotníckej politiky“, ale reálnymi klinickými premennými.

Autorka sa venuje dileme, či Medicare bude aj v budúcnosti platiť za obezitu ako za prevenciu, alebo bude naďalej hradiť predovšetkým to, na čo sa obezita neskôr pretaví. Kľúčovým bodom je plán BALANCE a následné zmeny okolo tzv. programu Medicare GLP-1 Bridge.

Prevencia verus manažment neskorších následkov

Článok opisuje model BALANCE ako snahu presunúť logiku systému od platenia „za chorobu až následne“ k plateniu „za prevenciu“ prostredníctvom drahých liekov (GLP-1). Model bol podľa textu koncipovaný tak, aby sa terapeutický liek kombinoval so sprievodnou behaviorálnou podporou, pričom časť implementácie mala

prebiehať postupne — najprv v programe Medicaid a potom v Medicare.

Pred spustením v Medicare však došlo k posunu: dočasný program Bridge sa predĺžil a trvalé riešenie zostalo nejasné. Z praktického hľadiska to znamená, že časový horizont dostupnosti liekov je pre časť pacientov kratší a neistý.

Medicare GLP-1 Bridge: čo je podstatné pre prax (a pre pacienta)

Text pracuje s myšlienkou, že počas „mostíkového“ (bridge) obdobia môžu niektorí poistenci s obezitou ako kvalifikačnou diagnózou získať vybrané lieky zo skupiny GLP-1 za zníženú mesačnú úhradu. Autorka zároveň zdôrazňuje, že ide o provizórny režim s obmedzenou dobou platnosti a že po jeho skončení sa zásadná otázka skôr odkladá, než rieši.

Pre nefrológa je z toho relevantné najmä toto:

- liečba obezity (GLP-1) môže byť pre CKD a kardiometabolické riziko nepriamo „časovo citlivá“,
- ak je dostupnosť nestabilná, zhoršuje sa adherencia aj dlhodobý prínos,
- v praxi potom často narážame na to, že pacient liečbu začne, no následne nastane prekážka v jej pokračovaní.

Pri rozhodovaní o konkrétnom pacientovi sa preto oplatí mať pripravený plán: zdokumentovať indikáciu a očakávaný prínos pre kardiometabolický profil aj renálne riziko a včas riešiť administratívne i logistické prekážky.

„Zaplatiť teraz, alebo zaplatiť neskôr“ nie je slogan, ale predikcia klinickej reality

Autorka stavia argumentáciu na jednoduchom kompromise: buď systém investuje do liečby obezity teraz, alebo zaplatí neskôr — za infarkt, zlyhanie srdca, dialýzu, endoprotézy a ďalšie nákladné následky.

V texte sú uvedené aj odhady úspor a dodatočných nákladov v horizonte niekoľkých rokov (z rôznych inštitúcií). Berme ich ako orientačné čísla, pretože skutočné výsledky závisia od:

- reálnej miery adherencie,
- podielu pacientov, ktorí liek dostanú a udržia dlhodobo,
- štruktúry populácie (komorbidity, štádiá CKD, diabetes),
- a od toho, ako presne sa v modeloch definujú „kompenzácie“ (offsety) nákladov.

Čo by mali odborníci komunikovať pacientom aj systému

Z článku pre mňa vychádzajú tri jasné body:

1. **Obezita je chronické ochorenie s merateľným rizikom pre obličky.** Pacientovi to zrozumiteľne vysvetlíme ako „investíciu do budúcnosti obličiek“, nie iba do hmotnosti.
2. **Neistota úhrady je klinický problém, nie administratívna drobnosť.** Pri pacientoch s CKD, diabetom a vysokým kardiovaskulárnym rizikom môže nestabilný prístup zhoršiť dlhodobé výsledky.
3. **Ak má pacient prístup k liečbe, kľúčové je myslieť na kontinuitu.** Aj keď článok rieši zdravotnú politiku, prakticky to znamená včas plánovať pokračovanie liečby, sledovať toleranciu a metabolické parametre a dokumentovať odpoveď.

Poznámka na záver

Ide o politicko-zdravotnícky materiál, ktorý sa môže meniť. Pri riešení konkrétnej dostupnosti pre pacienta v danom období odporúčam overiť aktuálne podmienky v primárnych zdrojoch (CMS a príslušné dokumenty k úhrade).

Zdroj: Amy Faith Ho, *Obesity Dilemma: Pay Now or Pay for What It Becomes Later*, Medscape (2026). [Link na zdroj](#).

